



Com Fourslim a fome não bate!



*Ativo 100%
natural altamente
eficaz na perda
de peso*

Uso: Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de equivalência: Não se aplica

Introdução

A obesidade é um grande desafio de saúde no mundo ocidental, tendo complicações clínicas graves como diabetes mellitus tipo 2, doenças cerebrovasculares e isquêmicas do coração.

O tratamento farmacológico para pacientes portadores de obesidade é limitado a anorexígenos tais como a anfepramona, a sibutramina e o orlistat, utilizado para reduzir a

absorção de gorduras os quais são responsáveis por diversos efeitos colaterais e comprometem a adesão do paciente ao tratamento.

Assim, a busca por ativos de origem natural, os quais oferecem eficácia comprovada, têm sido importante nas estratégias de busca e desenvolvimento, garantindo a segurança e qualidade, sem os efeitos adversos de um fármaco, promovendo saúde para os pacientes e a garantia de um tratamento eficaz e seguro.

Fourslim foi desenvolvido para atuar no gerenciamento do peso, demonstrando eficácia em estudos pré-clínicos *in vitro* e *in vivo*, incluindo ensaio em humanos.

Fourslim mostrou apresentar um alto nível de segurança, conforme medido em testes *in vitro*.

Descrição

Fourslim é um blend de extratos de folhas do manto de Lady (*Alchemilla vulgaris* L.), oliva (*Olea europaea* L.), hortelã selvagem (*Mentha piperita* / *longifolia* L.) e sementes de cominho (*Cuminum cyminum* L.), demonstrando ser eficaz e seguro na perda de peso.

Dentre os principais compostos fenólicos que compõe os extratos de Fourslim, tem-se: a oleuropeína (*Olea Europaea*), o ácido rosmarínico (*Mentha Longifolia*), a miquelianina (*Alchamilla vulgaris*) e o ácido p-cumarico (*Cumin Cyminun*). Em função da rica composição em moléculas fenólicas de cada extrato, tem-se a ação sinérgica de todos estes constituintes, potencializando seus efeitos no gerenciamento do peso, com estudos clínicos comprovados. Profundamente enraizada na medicina árabe, a *Alchemilla vulgaris* L. é utilizada no tratamento da obesidade, na dor gastrointestinal e na inflamação. As folhas de oliveira são um remédio herbal típico da região do Mediterrâneo e possui ação hipoglicemiante, propriedades hipotensora-diuréticas e antioxidantes. Os extratos de ambas as folhas dessas plantas demonstraram efeitos no aumento da taxa metabólica.

Durante séculos, a hortelã e o cominho foram utilizados para reduzir o apetite e para melhorar a digestão, aliviando sintomas digestivos como dor, espasmo, gases e dispepsia, criando assim uma sensação de plenitude.

Desta forma, a junção dessas 4 plantas permitiu o desenvolvimento de um ativo eficaz no gerenciamento do peso.

Estudos

Perda de Peso em Humanos: um estudo duplo cego controlado por placebo: Fourslim versus Placebo

Trinta e dois voluntários (Idades: 20-62, mulheres e homens) foram recrutados para participarem de um estudo onde foi avaliado o efeito da suplementação de Fourslim versus placebo no gerenciamento do peso. Para tal, os participantes seguiram um protocolo experimental, fornecendo a cada semana, suas medidas de peso e cintura, além de responderem a um questionário de escala visual analógica (VAS) para o apetite, desejo por doces e movimentos intestinais. A pontuação 5 indica excelente enquanto que a pontuação 1 está relacionada com um resultado ruim.

Os participantes foram randomizados em 2 grupos (Fourslim e Placebo) e foram avaliados no início, após 4 e após 8 semanas de estudo. Eles foram orientados a tomarem as cápsulas contendo Fourslim ou Placebo 30 minutos antes das refeições.

Observou-se uma redução de peso significativa e progressiva durante o período de teste de 8 semanas, em média 0,48 kg / semana durante 8 semanas. O peso foi reduzido de (Basal) de $78,1 \pm 14,9$ para $74,3 \pm 13,9$ após 8 semanas ($p < 0,005$).

Da mesma forma, uma perda de peso progressiva e significativa foi observada no IMC. A média de redução no IMC foi significativa ($p < 0,005$), de $26,9 \pm 4,5$ para $25,6 \pm 4,1$.

Uma redução significativa ($p < 0,005$) na linha da cintura foi observada após 8 semanas. A redução média foi de (Basal) $93,0 \text{ cm} \pm 12,4$, para $85,5 \text{ cm} \pm 11,9$ na semana 8. Nenhum efeito significativo foi observado no grupo Placebo.

Uma melhora significativa foi vista na redução do apetite, no desejo por açúcar e na melhoria de movimentos intestinais no grupo Fourslim comparado ao grupo controle Placebo. Uma redução significativa do apetite foi observada de (Basal) $3,8 \pm 0,8$ para $4,2 \pm 0,7$ na semana 8, uma redução significativa no desejo por doces foi observada de (Basal) $4,1 \pm 0,9$ para $4,8 \pm 0,4$. Da mesma forma, observou-se uma melhoria no movimento intestinal de (Basal) $4,2 \pm 0,8$ para $4,3 \pm 0,3$ na semana 8 para o grupo Fourslim. Nenhum efeito significativo, desses parâmetros, foi observado no grupo Placebo.

Avaliação do Apetite

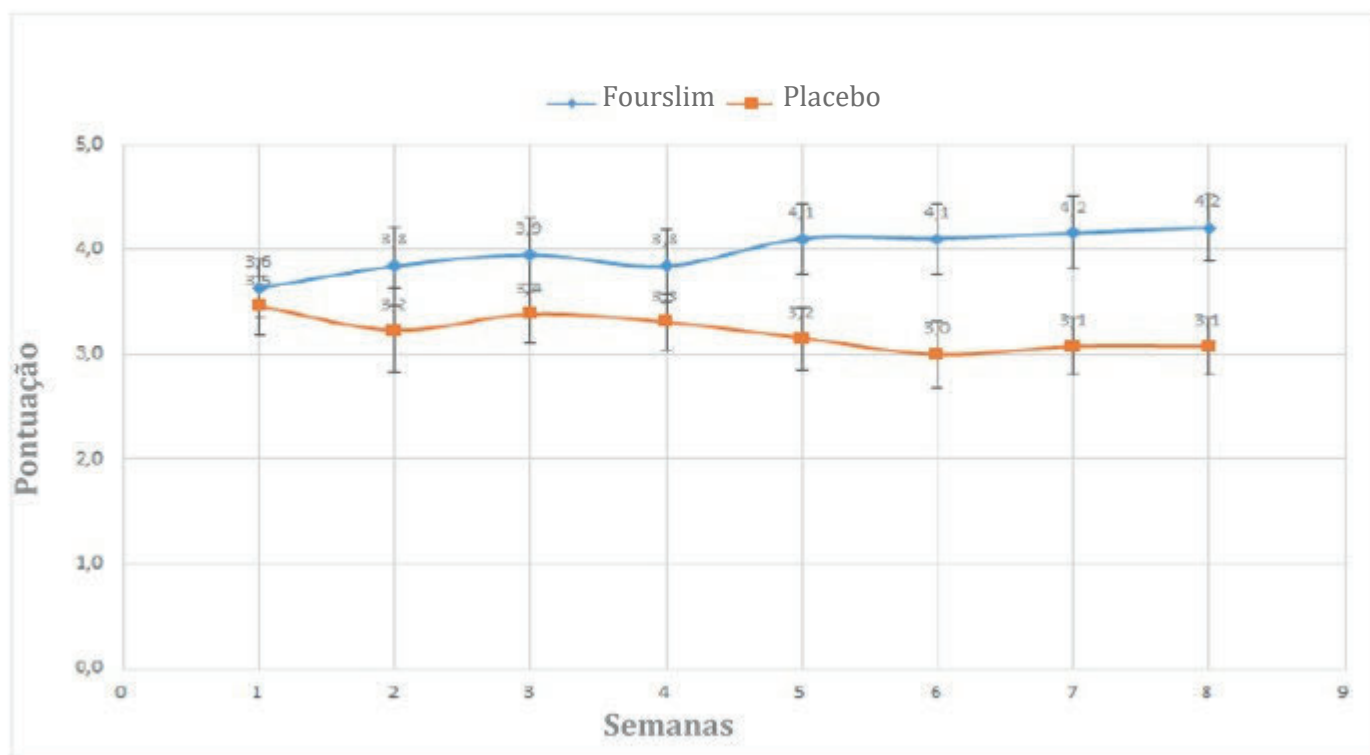


Figura 1: Comparação da redução de apetite: Eficácia do Fourslim na redução do apetite na semana 4 ($3,8 \pm 0,8$) e na semana 8 ($4,2 \pm 0,7$) comparados ao grupo Placebo na semana 4 ($3,3 \pm 0,8$) e na semana 8 ($3,1 \pm 0,7$).

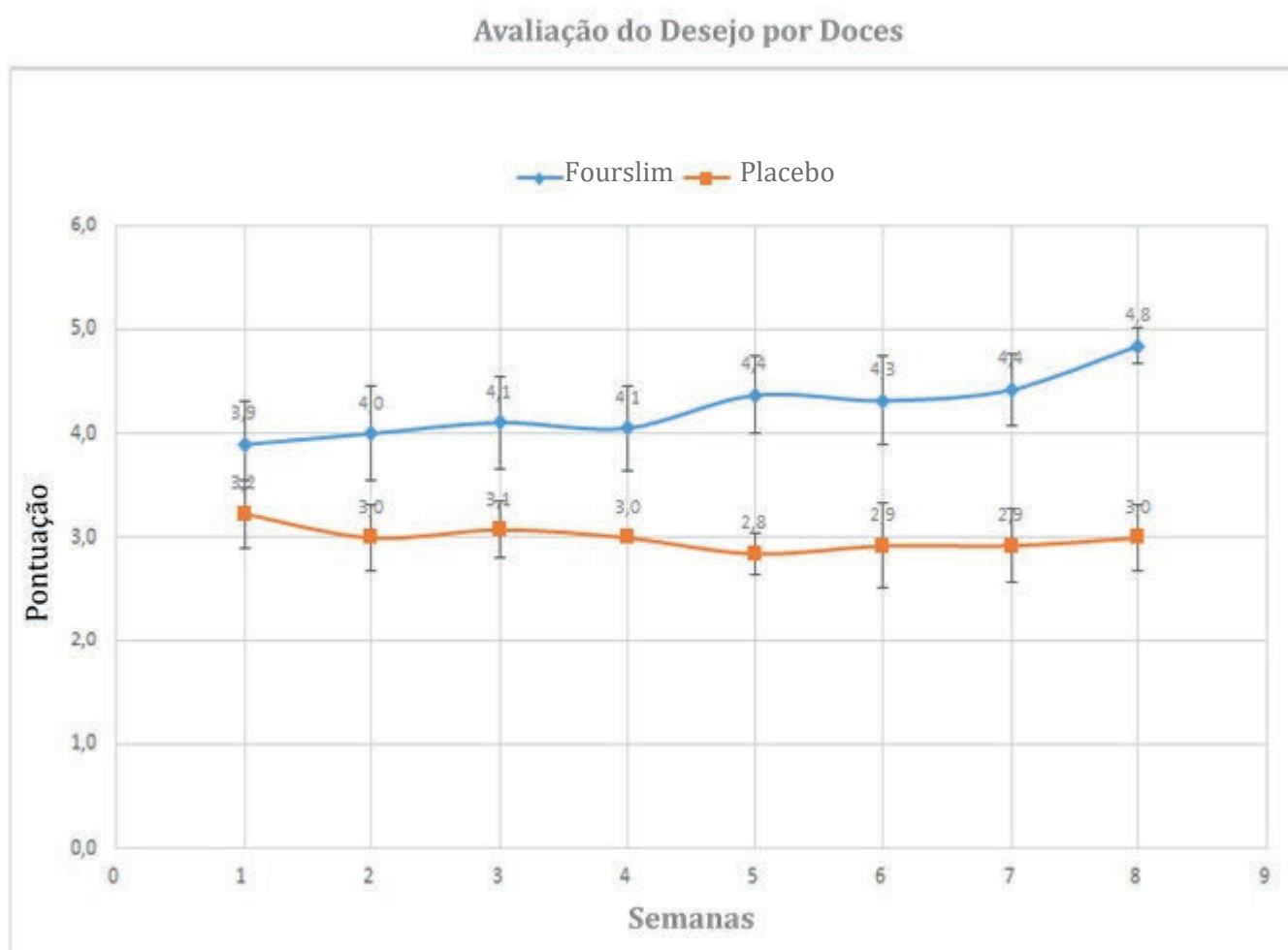


Figura 2: Comparação da redução do desejo por doces: Eficácia do Fourslim na redução do desejo por doces na semana 4 ($4,1 \pm 0,9$) e na semana 8 ($4,8 \pm 0,4$) comparado ao grupo Placebo na semana 4 ($3,0 \pm 0,0$) e na semana 8 ($3,0 \pm 0,6$).

Avaliação da Movimentação Intestinal

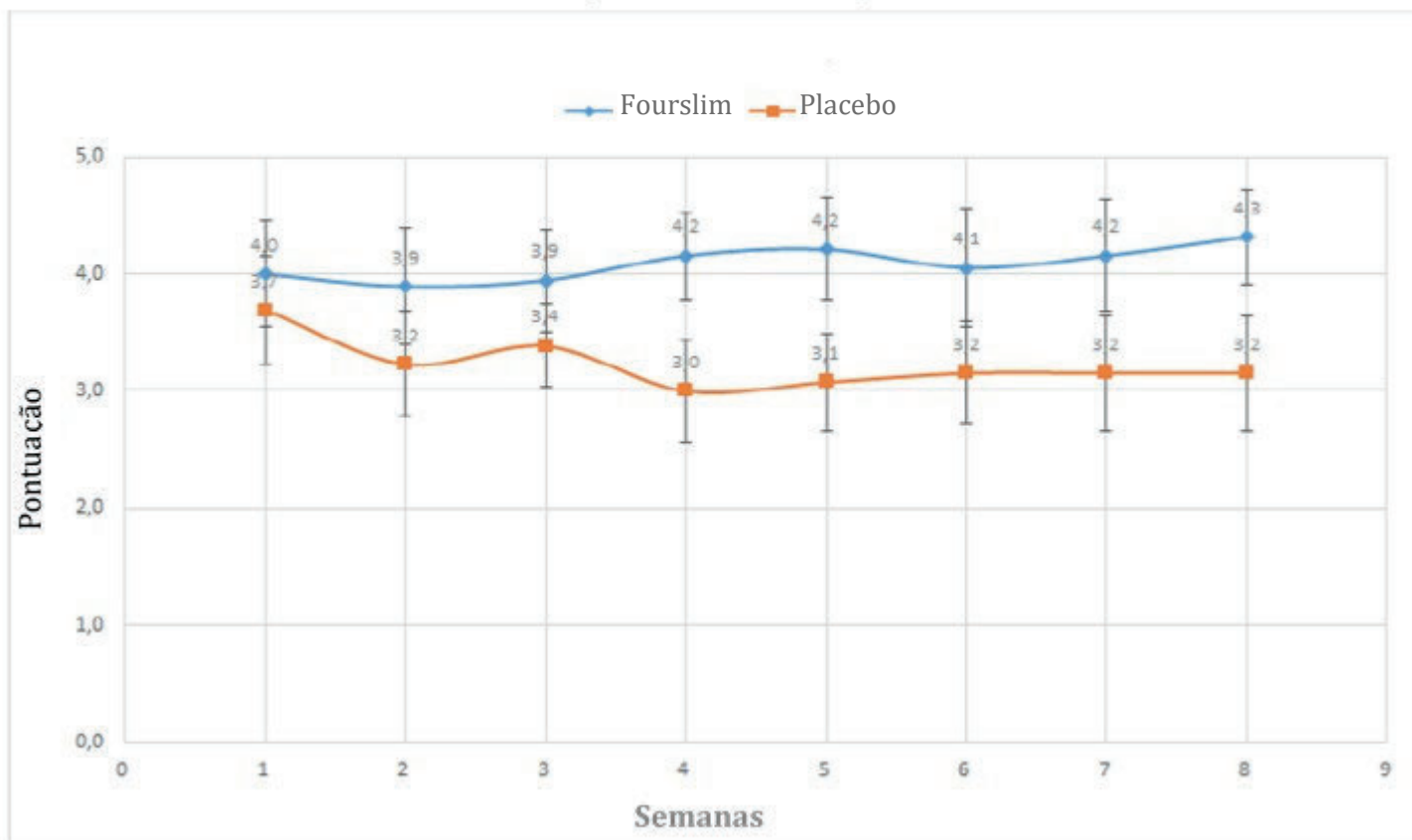


Figura 3: Comparação de melhoria nos movimentos intestinais: Eficácia do Fourslim na melhora dos movimentos intestinais na semana 4 ($4,2 \pm 0,8$) e na semana 8 ($4,3 \pm 0,3$) comparar com o grupo Placebo na semana 4 ($3,0 \pm 0,8$) e na semana 8 ($3,2 \pm 0,9$).

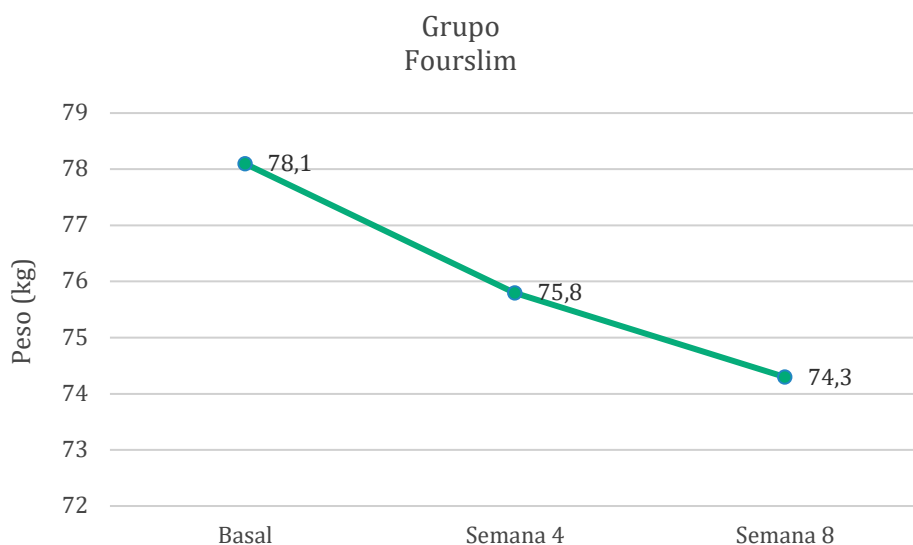


Figura 4: Eficácia de Fourslim na perda de peso (em kg) no grupo Fourslim (n = 19). Houve uma redução progressiva de peso durante o período do estudo de 8 semanas, com média de 0,48 kg / semana durante 8 semanas. O peso foi reduzido de $78,1 \pm 14,9$ para $74,3 \pm 13,9$ após 8 semanas ($p < 0,005$).

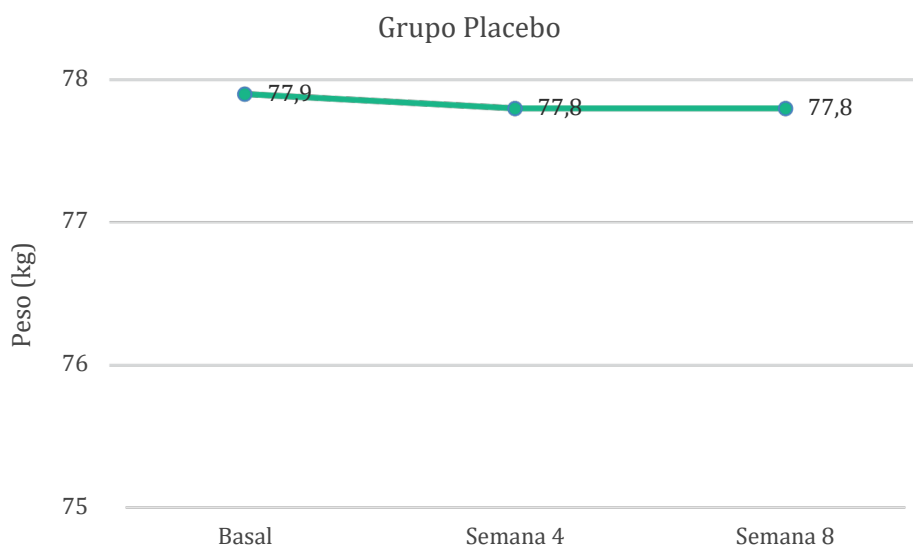


Figura 5: Perda de peso (em kg) no grupo placebo (n = 13). Não foi observada uma redução no peso dos voluntários durante o período de teste de 8 semanas, com média de 0,04 kg / semana.

Perda de Peso em Humanos: Fourslim versus Placebo

34 Voluntários (mulheres e homens) foram selecionados para participar de um estudo para avaliar a eficácia de Fourslim na redução do peso ao longo de 3 meses. Os voluntários foram divididos em dois grupos: Fourslim ou Placebo e foram orientados a tomarem o ativo ou o placebo 30 minutos antes das principais refeições. As medidas de peso foram feitas no início, após 1, 2 e 3 meses de estudo.



Figura 6: Eficácia de Fourslim na média da redução de peso (kg) ao longo de 3 meses.

Os resultados obtidos mostram que o peso foi reduzido de $93,5 \pm 7,9$ kg para $84 \pm 9,8$ kg após 3 meses ($p < 0,0005$) para o grupo Fourslim.

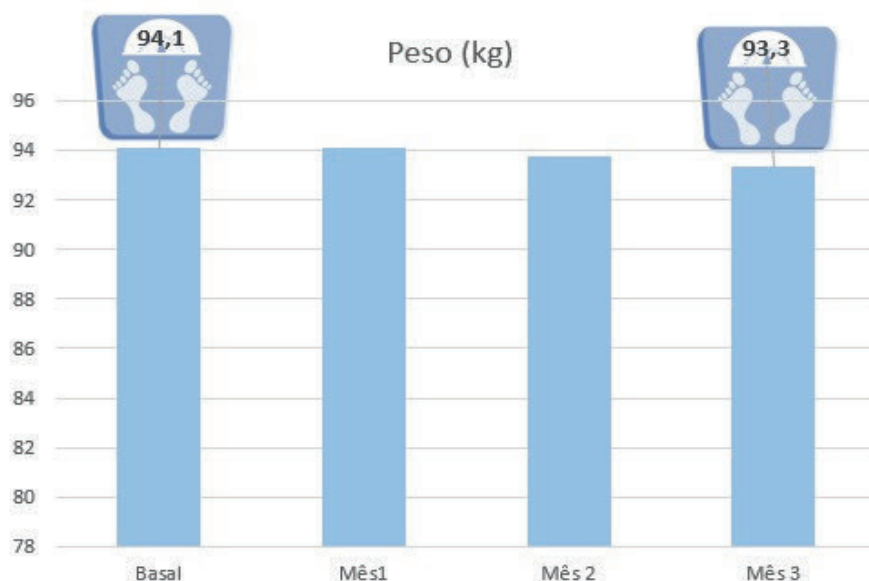


Figura 7: Eficácia do Placebo na média da redução de peso (kg) ao longo de 3 meses.

Os resultados obtidos mostram que não houveram reduções significativas de peso no grupo Placebo.

Indicações

- Gerenciamento da perda de peso;
- Aumenta o metabolismo das gorduras;
- Ajuda a suprimir o apetite.

Reações Adversas

Não foram relatadas reações adversas nos estudos.

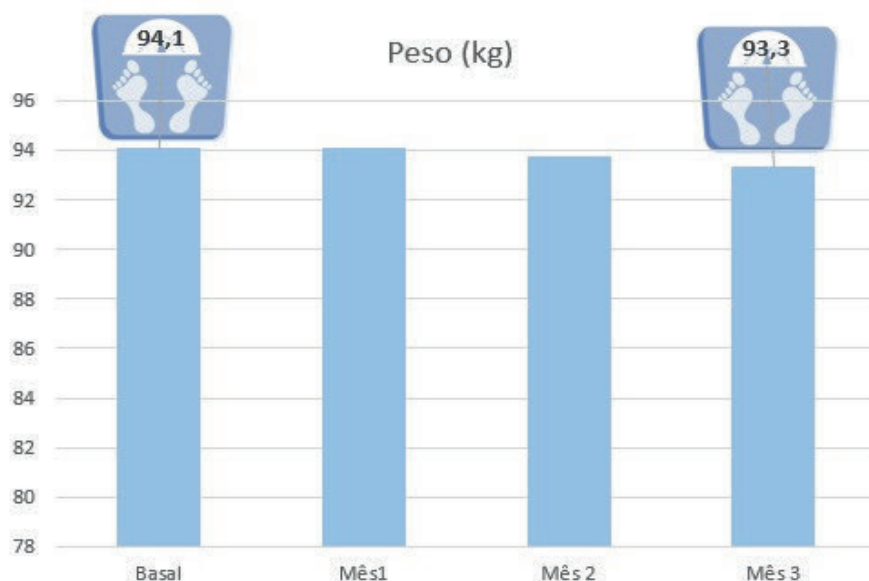


Figura 7: Eficácia do Placebo na média da redução de peso (kg) ao longo de 3 meses.

Os resultados obtidos mostram que não houveram reduções significativas de peso no grupo Placebo.

Indicações

- Gerenciamento da perda de peso;
- Aumenta o metabolismo das gorduras;
- Ajuda a suprimir o apetite.

Reações Adversas

Não foram relatadas reações adversas nos estudos.

Concentração Recomendada

Dose diária recomendada para adultos: 150mg 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, totalizando 450mg ao dia . A dosagem recomendada diária não deve ser excedida.

Referências Bibliográficas

- Halpern A, Mancini MC. Treatment of obesity: an update on anti-obesity medications. *Obes Rev* 2003; 4: 25-42.
- Omar Said, Bashar Saad, Stephen Fulder, Khaled Khalil, Eli Kassis. Weight loss in animal and humans treated with “Fourslim”, a combination of four medicinal plants used in traditional Arabic and Islamic Medicine Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011, Article ID 874538, 6 pages. doi:10.1093/ecam/nen067
- Omar Said, Bashar Saad, Stephen Fulder, Khaled Khalil, Eli Kassis. A double blinded randomized clinical study with “Fourslim”, a combination of four medicinal plants used in traditional Greco-Arab and Islamic medicine, *The Open Complementary Medicine Journal*, 2010,2, 1-64. The complete German Commission E monographs; *Integrative Medicine* 1999.
- Ibn Rassool Alturkmani: *Almaatammad Fi Aladwiya Almufrada*. Cairo, Dar AlKutub Alarabiya. 1930; pp 319, 432 and 525.
- Said O, Khalil K, Fulder S, Azaizeh H. Ethnopharmacological survey of the Medical herbs in Israel, the Golan Heights and the West Bank. *Journal of Ethnopharmacology* 2002; 83:251-63.
- Pinelli P, et al. Quali-quantitative analysis of antioxidant activity of different Polyphenolic extracts from *Olea europea* L. L. leaves. *Journal of Commodity Science* 2000; 39: 71-83.
- Borodin Iul, Seliatitskaia VG, Obukhova LA, Pal`chikova NA, Odintsov SV, Kukushkina TA. Effect of polyphenol fraction of *Alchemilla vulgaris* L. on the morphofunctional state of the thyroid in rats exposed to cold. *Biull Eksp Biol Med* 1999; 127: 697-99.

Al-Qarawi AA, Al-Damegh MA, El-Mougy SA. Effect of freeze dried extract of Olea europea on the pituitary-thyroid axis. *Phytotherapy Research* 2002; 16: 286-7.

May B, Kohler S, Schneider B. Efficacy and tolerability of a fixed combination: Peppermint oil and caraway oil in patients suffering from functional Dyspepsia. *Aliment Pharmacol Therapy* 2000; 14:1671-77.

Martendale, The Extra Pharmacopoeia. Section on Aromatic Carminatives. The Pharmaceutical Press. London; 2001.

Omar Said, Khaled Khalil, Stephen Fulder, Yousaf Marie, Eli Kassis and Bashar Saad. A Double Blinded- Randomized Clinical Study with "Fourslim", a Combination of Four Medicinal Plants Used in Traditional Greco-Arab and Islamic Medicine. *The Open Complementary Medicine Journal*, 2010, 2, 1-6.